

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	動脈導管穿刺術及動脈導管抽血法 評核表	編號	A31000-Q06-F-B34
	制定 單位	護理部	版本	第 2.6 版
			修正日期	113 年 07 月 02 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：重症加護單位護理人員。

二、評核方式：實地查核或由護理人員口述協助動脈導管穿刺術及動脈導管抽血之步驟。

三、評核內容：

1. 導管置放前之準備：

a. 確認同意書是否簽署完成，核對電腦住院護理系統，於護理執行核對狀態核簽“正確”。

b. 將 500ml 生理食鹽水軟袋接上 A-line set，置於加壓袋中，充氣到 300mmHg，接上壓力導線，並採無菌技術予以排氣將空心蓋換上實心蓋，注意勿使氣泡存於壓力傳導系統管路之中。

2. Allen 試驗：

a. 讓病人的手用力握拳，將其橈動脈和尺動脈壓住。

b. 當患者手掌打開時，鬆開尺動脈側，觀察手掌回復紅潤顏色之時間，如在 6 秒內回復，表示尺動脈通暢且有完好的掌弓側枝循環；如在 7-15 秒才回復顏色，表示尺動脈充填很慢，一直蒼白到 15 秒以上，則表示側肢循環不好。

註：(1)若病人意識不清則採被動式的幫病患握掌，以評估之。

(2)測試橈動脈枝通暢與否，可用相同方法，但放壓力處改為橈動脈。

3. 協助導管置放：

a. 醫師以無菌技術觸摸脈搏位置，動脈較常穿刺位置：橈動脈、肱動脈；較少穿刺位置：股動脈、足背動脈。

b. 調整 ABP(Arterial Blood Pressure)之警告數值，且使監視器顯示出其正常波形。

c. 留置動脈導管 3 天更換或拔除，若肢體末梢缺血、顏色改變（發紺、瘀青），應立即拔除動脈導管。

註：(1)每隔八小時應檢查一次監測器之高度位置及零點，每班檢查接頭處是否有鬆脫情形，並校正監視器一次。

(2)病人若有不明原因發燒、局部症狀或血流感染，應檢視導管注射部位情形。

(3)拔除留置動脈導管需要徒手加壓 5 分鐘，確認未有出血的情況才能覆蓋紗布、膠布固定，若有血腫、有再出血情況或者動脈阻塞（觀察 6Psign），立即告知醫師處理。

4. 動脈導管抽血：

a. 以 3c.c.空針連接三路活塞接頭，關監視器端，抽出約 3c.c.血液（前端生理食鹽水）後，三路活塞旋轉恢復原位。

b. 取下 3c.c.空針，以 ABG 空針連接三路活塞接頭，關向通往監視器端，抽出所需的血液量後，三路活塞關向病人端。

c. 按沖洗鈕將三路活塞內之殘餘血液沖至空針袋，三路活塞旋轉恢復原位。

d. 以酒精消毒三路活塞接頭及實心蓋內側，將實心蓋放回三路活塞接頭。

e. 按沖洗鈕，將連接管之血液沖回血管內，並注意監視器之動脈壓力波是否正常。

